

主诉知识图谱 · 标准结构定义

主诉表1 | 主诉入口标准化表（每个主诉 1 行）

字段（中文）	填写内容	示例
主诉编号	主诉唯一标识	CC_001
主诉标准名（中文）	标准主诉名称	水肿
主诉定义	一句话定义“用户在抱怨什么”，不写诊断	组织间液体增多导致的肿胀表现
包含范围	条目化（3-8 条）	下肢肿胀；眼睑肿胀；手足肿胀
排除范围	条目化（3-8 条）	局部肿块；明确外伤后的局部肿痛；单纯体重增加无肿胀
适用人群	成人 / 儿科 / 孕产等（可多选）	成人；孕产
适用场景	全科 / 急诊 / 专科 / 健康管理等（可多选）	全科；急诊
默认入口方向	症状诊断 / 健康管理 / 混合	症状诊断
最小关键字段配置	引用主诉表2	见主诉表2
危险信号清单引用	引用规则层 ID	RULE_RED_FLAG_XXX
收敛 / 停止条件引用	引用规则层 ID	RULE_STOP_XXX
升级 / 转诊触发引用	引用规则层 ID	RULE_ESCALATE_XXX
版本号 / 更新时间	便于迭代	v0.1 / 2026-01-28

主诉表2 | 最小关键字段配置表（一行 = 1 个信息点）

信息点	必填等级	标准问法（原话）	答案口径（简写）	缺失处理
起病时间与过程	必须	什么时候开始的？突然还是慢慢加重？	突然 / 渐进 / 不确定 + 时长	必须补齐
部位 / 范围	必须	具体哪里不舒服？是一点还是一片？	标准部位（可多选）	必须补齐

信息点	必填等级	标准问法（原话）	答案口径（简写）	缺失处理
分布	必须	是一侧明显还是两侧差不多？	单侧 / 双侧 / 局部 / 不确定	必须补齐
性质	必须	更像刺痛、压着、灼烧还是闷胀？	固定词 + 不确定	必须补齐
严重度	必须	0 到 10 分你给几分？	0-10 / 不确定	必须补齐
诱因	重要	什么情况下出现或加重？	运动 / 进食 / 体位 / 情绪 / 外伤	可继续但降级
缓解因素	重要	休息或用药后会缓解吗？	有 / 无 / 不确定	可继续但降级
伴随症状	重要	同时还有哪些不适？	3-5 个标准症状	可继续但降级
关键背景	重要	有相关既往史 / 用药 / 妊娠 / 暴露吗？	有 / 无 / 不确定	可继续但降级
危险信号自检	必须	有没有晕厥 / 大汗 / 明显呼吸困难？	有 / 无 / 不确定	命中走兜底

主诉表3 | 主诉澄清规则表（最小分叉问题集）

说明：

- 本表基于《主诉澄清规则.md》的通用规则框架填写
- 每个特定主诉组合的澄清规则是对通用规则（如G2、G3等）的优化和细化
- 当系统识别出特定主诉组合时，优先使用本表中的特定规则；如果未找到匹配，则降级到通用规则
- 所有规则必须遵循通用框架的约束：E≤2（入口最多2个）、安全优先、澄清轮次上限2个问题

触发情况（哪些主诉同时出现）	最小澄清问题	答案选项	判定结果	不确定兜底
胸闷 + 呼吸困难	你主要是不够气/喘不上气，还是胸口压闷为主？	不够气 / 压闷 / 两者都有 / 不确定	不够气→呼吸困难； 压闷→胸闷；两者都有→并行保留	并行保留 + 先走危险信号兜底

主诉表4 | 鉴别诊断框架子类表（Step2 分组）

框架类型	子类名称	子类边界	子类候选疾病集合（只写疾病名/ID列表）	must-not-miss（必须优先除外）	后续优先差异点
分布分叉	单侧	以单侧为主的表现	疾病A；疾病B；疾病C	疾病B	PP_01；PP_02

主诉表5 | 三层候选总览表（每个主诉 1 行）

Tier1 最可能	Tier2 必须优先除外	Tier3 积极备选	分层口径
常见方向组A	高危不能漏组B	易混淆组C	Tier2 按 must-not-miss 优先；Tier1 按匹配度与阳性线索

主诉表6 | 候选疾病明细表（Step2 落地）

疾病	默认层级	入选依据	当前支持线索	当前反对线索	待补齐缺口	首选获取方式（追问/检查）
疾病B	Tier2	漏诊后果严重且符合现有表现	单侧；突发；高危背景	无发热	起病速度；疼痛强度	追问（必要时检查）

主诉表7 | 推理子组清单表（Step3 线索簇）

子组名称	覆盖疾病（列表）	子组进入触发（线索标题）	推进目标	优先补齐缺口（线索标题）	推进路径（追问/检查/混合）
血栓风险线索组	疾病B；疾病D	单侧；突发；久坐久卧	优先排除高危方向	起病速度；疼痛；呼吸症状	混合

主诉表8 | 关键差异点配置表（Step4）

差异点名称	标准问法	答案选项	影响子组 / 疾病	动作（前移/后移/保留/触发检查/触发升级）	阴性限制	不确定处理
单侧 vs 双侧	是一侧明显还是两侧差不多？	单侧 / 双侧 / 不确定	血栓风险组；回流受阻组	单侧→前移血栓风险；双侧→前移回流受阻	双侧不能直接排除血栓，仅后移	两组并行保留继续问下一差异点

主诉表9 | 检查 / 检验建议与结果解释

检查项目	建议时机	目的（支持/排除哪些方向）	关键结果理解	影响范围（子组/疾病）
心电图	Tier2 触发或症状加重	支持 / 排除高危心源性	异常=支持；正常≠排除	上调 / 下调方向组

主诉表10 | 回填、重排、收敛触发点（闭环）

触发情况（发生了什么）	动作（更新/调整/输出/升级）	影响范围（哪些子组/疾病）	引用规则层
命中危险信号	中断常规问诊 → 安全兜底	所有候选整体上调	风险识别 + 安全兜底
关键反驳线索出现	下调或移出方向	对应疾病	回填与重排
证据充分且收敛	输出结论包	最终 1-2 个方向	收敛停止